



Diagnóstico diferencial en la infancia, apoyo psicológico en reproducción asistida y nuevas obligaciones para centros: claves del 22 de junio de 2026

LUNES 22 DE JUNIO DE 2026

Resumen rápido del día

El Institut de la Ment Infantil publica una guía sobre los errores diagnósticos más frecuentes en la infancia y la adolescencia, subrayando que síntomas como la desatención o el comportamiento disruptivo pueden tener múltiples causas y exigen una evaluación multidimensional antes de concluir el diagnóstico. Una revisión en Human Reproduction documenta la elevada carga psicológica asociada a la infertilidad —con prevalencias de ansiedad entre el 25% y el 54% y de depresión entre el 28% y el 44%— y señala que las intervenciones psicológicas, especialmente la terapia cognitivo-conductual y las intervenciones mente-cuerpo, se asocian con reducción del malestar y mejoras en las tasas de embarazo. Por su parte, un estudio de la Universidad Complutense de Madrid publicado en Ansiedad y Estrés muestra que un programa estructurado de gestión del tiempo se asocia con mayor eficacia académica y menores niveles de ansiedad en estudiantes universitarios. En el plano normativo, el Real Decreto 239/2026 entra en vigor el 1 de julio y establece la obligación permanente de acreditar la titulación habilitante de todo el personal sanitario en consultas y centros de psicología, con plazo de adaptación hasta el 1 de enero de 2027.

Noticias nacionales

El Real Decreto 239/2026 establece la acreditación permanente de titulación en consultas y centros de psicología

El Real Decreto 239/2026, de 25 de marzo, publicado en el BOE, entra en vigor el 1 de julio de 2026 e introduce una obligación permanente: los centros, consultas y unidades asistenciales de psicología deberán garantizar en todo momento que la atención sanitaria es prestada por profesionales con la titulación oficial habilitante, ya sea el título de Especialista en Psicología Clínica o el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria junto con el Grado o Licenciatura en Psicología. La norma exige mantener un expediente personal actualizado de todo el personal sanitario, independientemente de su modalidad contractual, vinculación jurídica o formato de atención —presencial o telemática—. Las consultas y centros disponen hasta el 1 de enero de 2027 para tener en regla la información y documentación de su plantilla. La reforma afecta también a los profesionales que colaboran por horas, sesiones o mediante contrato mercantil, y obliga a informar a las nuevas incorporaciones sobre las prácticas seguras del centro.

Fuente: Infocop — Consejo General de la Psicología de España

Un programa de gestión estratégica del tiempo mejora la eficacia académica y reduce la ansiedad en universitarios

Investigadores de los Departamentos de Psicología Social y del Trabajo y de Psicobiología y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid han evaluado un programa estructurado de gestión estratégica del tiempo aplicado a 164 estudiantes de cuarto curso. El estudio, publicado en la revista *Ansiedad y Estrés*, adoptó un diseño longitudinal con tres momentos de evaluación. Los resultados muestran que el grupo experimental presentó niveles más bajos de ansiedad en los tres momentos de evaluación frente al grupo control, mayor percepción de eficacia académica, así como menores niveles de confusión y descontrol emocional. El programa, compuesto por ocho actividades secuenciadas —incluyendo análisis DAFO personal, autorregistro del tiempo, planificación por objetivos y organización en

calendario semanal y mensual—, ofrece un formato de intervención breve y estructurada que los autores consideran adecuado para implementar en el contexto universitario como herramienta de promoción del bienestar psicológico.

Fuente: Infocop — Consejo General de la Psicología de España

CLÍNICA · NACIONAL

El apoyo psicológico en reproducción asistida reduce el malestar y puede favorecer la continuidad del tratamiento

Una revisión publicada en *Human Reproduction* examina la prevalencia de síntomas psicológicos en personas con infertilidad y su relación con el abandono de los tratamientos de reproducción asistida. Los estudios revisados documentan cifras significativas: en cohortes con tratamiento activo, entre el 56,5% de las mujeres y el 32,1% de los hombres presentaban rangos clínicos de depresión, y el 75,9% de las mujeres y el 60,6% de los hombres mostraban niveles clínicos de ansiedad. Un metaanálisis de 2022 que incluyó a 124.556 mujeres en todo el mundo identificó asociación significativa entre infertilidad y malestar psicológico y depresión. La revisión señala que la terapia cognitivo-conductual y las intervenciones mente-cuerpo se asocian con mejoras en síntomas de ansiedad y depresión y con aumentos en las tasas de embarazo. Aunque la evidencia específica sobre la influencia en la continuidad del tratamiento es todavía limitada, algunos estudios preliminares apuntan a que las intervenciones más estructuradas y sostenidas pueden reducir el abandono terapéutico.

Fuente: Infocop — Consejo General de la Psicología de España

Noticias internacionales

CLÍNICA · INTERNACIONAL

Errores de diagnóstico en la infancia: cinco confusiones frecuentes que exigen evaluación diferencial

El Child Mind Institute (Instituto de la Mente Infantil, EE.UU.) ha publicado un artículo recogiendo los errores diagnósticos más comunes en población infantil y adolescente. La guía identifica cinco situaciones de confusión frecuente: la desatención puede deberse a ansiedad, TOC o dificultades de aprendizaje antes que a TDAH; los pensamientos repetitivos angustiosos pueden corresponder a TOC y no a TEPT; las dificultades de comunicación pueden reflejar mutismo selectivo y no trastorno del espectro autista; la tristeza y la fatiga pueden tener causa médica como el hipotiroidismo antes de concluir depresión; y el comportamiento disruptivo puede originarse en ansiedad, TDAH o frustración por dificultades de aprendizaje antes que en trastorno negativista desafiante. Los expertos del instituto subrayan que una evaluación exhaustiva que contemple el contexto de vida del menor, sus relaciones y su desarrollo es esencial para evitar diagnósticos precipitados y garantizar la intervención adecuada.

Fuente: Infocop, a partir de artículo del Child Mind Institute

Herramientas clínicas e instrumentos

– Protocolos de evaluación diagnóstica diferencial en infancia y adolescencia:

Los marcos de evaluación psicológica multidimensional validados para población infantil y adolescente permiten discriminar entre trastornos con presentación sintomática similar —como TDAH, ansiedad, TOC, TEA o dificultades específicas del aprendizaje— considerando el contexto de vida del menor, sus relaciones sociales y su historia de desarrollo. Su aplicación sistemática puede reducir el riesgo de diagnósticos precipitados con impacto directo en la orientación terapéutica.

Prioridades del día

Revisar la documentación del personal antes del 1 de julio

Con la entrada en vigor del Real Decreto 239/2026 el 1 de julio de 2026, puede ser oportuno realizar una revisión interna del personal que presta atención en el centro —incluyendo colaboradores externos y profesionales en formato

telemático— y verificar que se dispone de copia de las titulaciones habilitantes correspondientes antes de esa fecha.

Considerar la evaluación diferencial en casos de presentación clínica compleja en menores

La evidencia recogida por el Child Mind Institute sugiere que síntomas frecuentes en la infancia y adolescencia —como la desatención, el comportamiento disruptivo o las dificultades de comunicación— pueden tener múltiples causas subyacentes. Puede ser relevante incorporar una exploración diferencial sistemática antes de orientar el diagnóstico, contemplando ansiedad, TOC, dificultades de aprendizaje o factores contextuales como posibilidades a descartar.

Los datos revisados en Human Reproduction señalan prevalencias elevadas de ansiedad y depresión en personas en tratamiento de reproducción asistida y su relación con el abandono terapéutico. Para profesionales que trabajan con estas poblaciones, puede ser útil explorar el encaje de intervenciones psicológicas estructuradas —especialmente TCC y técnicas de manejo del estrés— como complemento al tratamiento médico, aunque la evidencia específica sobre continuidad del tratamiento es todavía preliminar.